

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001054-67.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ESTER SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE ADRENALINA (EPINEFRINA) AUTOINJETÁVEL AO AUTOR, PARA TRATAMENTO MÉDICO. PARECER DO NAT. DOCUMENTOS MÉDICOS MENCIONAM A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO REQUERIDO POR OUTROS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a decisão do evento 3, para determinar que os réus, de forma solidária, forneçam à parte autora o medicamento adrenalina autoinjetável (Penepin), conforme prescrição do seu médico assistente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob multa diária de R\$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser aplicada no juízo de origem, devendo a parte autora apresentar receita médica atualizada a cada 6 (seis) meses. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5001054-67.2025.4.02.5101

510015379750 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001054-67.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ESTER SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) interposta pela parte autora em face de decisão dos autos originários, que indeferiu o fornecimento da medicação adrenalina autoinjetável (Penepin) 0,3mg/(2 seringas) à autora, menor impúbere, com quadro grave de alergia à proteína do leite de vaca.

Sustenta a parte autora que, de acordo com o laudo médico anexo à inicial, lavrado pela pediatra Dra. Isadora Arantes (CRM: 52.116650-6), a autora, acompanhada regularmente no Serviço de Alergia e Imunologia do IPPMG/UFRJ, apresenta grave quadro de alergia à proteína do leite de vaca com reações de anafilaxia em caso de contato acidental. Tal condição expõe risco à vida por gerar parada cardiorespiratória de forma aguda e óbito. Diante do quadro agravado, a recorrente necessita da disponibilidade da adrenalina autoinjetável para evitar as severas consequências, inclui-se óbito, de uma possível reação indesejada decorrente do contato com o leite de vaca.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela revogação da tutela.

Pedido liminar deferido no evento 3.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, a preservação da saúde é dever genérico solidário de todas as entidades federativas (art. 23, II e 196, CF/88). No entanto, as atribuições públicas específicas no campo da saúde, são descentralizadas, sendo a responsabilidade limitada à própria esfera de atribuições definidas em lei, conforme dispõem os art. 197 e 200 CF/88.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da obrigação estatal prevista no art. 196 da Constituição Federal, reconheceu a responsabilidade solidária dos três entes federativos para prestar serviços de saúde à população. Neste sentido:

*EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. **O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.** Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014)*

O art. 6º, I, "d", da Lei Federal 8.080/90 ("Lei") preconiza que a assistência farmacêutica se encontra inserida nas ações do SUS. E, por sua vez, o art. 19-M, I, da Lei, ao detalhar a maneira como se desenvolve essa assistência farmacêutica, prevê o dever de dispensação de medicamentos (i) cuja prescrição esteja em conformidade com o Protocolo Clínico e as Diretrizes Terapêuticas (PCDT) elaborado pelo SUS para a doença ou, (ii) na falta desse PCDT, desde que o medicamento esteja arrolado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja criação está a cargo do Ministério da Saúde.

Portanto, em regra, os entes federativos são obrigados a fornecer medicamentos à população desde que a prescrição médica esteja de acordo com o PCDT ou, em não havendo, deve constar da RENAME, também conhecida como Lista do SUS.

Todavia, o fato de o medicamento prescrito constar da RENAME não conduz à responsabilidade automática de fornecimento por todos os entes federativos, uma vez que, consoante o teor do art. 19-P, I, da Lei, a dispensação de medicamentos na hipótese de inexistência de PCDT ocorrerá com base na RENAME, mas a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Com efeito, tendo em vista que, nos termos do art. 24, XII, da Constituição da República, a competência para proteção e defesa da saúde é concorrente, logo cada ente poderá elaborar a sua própria lista de medicamentos, de forma suplementar à União.

Nesse cenário, cabe encaminharmos a resposta ao problema do dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Sobre o fornecimento de tais medicamentos por decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal, no dia 22 de maio de 2019 quando do julgamento do Recurso Extraordinário 657.718, de relatoria do ministro Luís Roberto Barros, fixou tese com afirmação de repercussão geral sobre a matéria, pacificando o entendimento de que em regra o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária por intermédios de decisões judiciais pois o registro no órgão constitui proteção à saúde pública, garantindo a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país.

STF- REPERCUSSÃO GERAL- RE 657.718

*O Tribunal, apreciando o tema 500 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Dias Toffoli (Presidente). Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: "1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra raras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) **a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.** 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União".*

Conforme o Recurso Extraordinário 657.718/MG, voto do Exmo. Ministro Luis Roberto Barroso, é possível flexibilizar o requisito da falta de registro na ANVISA, quando há prova de irrazoável mora da ANVISA em apreciar o pedido, superior a 365 dias, nos seguintes casos:

1- existência do requerimento de registro de medicamento no Brasil;

2- existência de registro desse medicamento em renomadas agências de regulação estrangeiras;

Em relação aos Medicamentos Experimentais o voto vencedor do ministro Barroso determinou que não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los, isso, sem interferir com a eventual utilização desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo.

Por sua vez, em relação aos medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas que ainda não foram submetidos ou concluíram todas as fases de aprovação da Anvisa, o relator explicou que a sua disponibilização deve possuir “caráter absolutamente excepcional” e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a demora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo dos três requisitos supracitados.

Em relação ao uso de medicamentos de maneira alternativa as suas finalidades terapêuticas precípuas (uso off label) o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial 1.657.156 (recurso repetitivo) fixou a tese segundo a qual é obrigação do poder público fornecer medicamentos para situações não previstas na bula registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde que presentes três requisitos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Em sede de embargos de declaração houve a complementação do julgado acima com esclarecimentos e a modulação de efeitos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 494, I, DO CPC/2015. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO REPETITIVO.

1. O inciso I do art. 494 do CPC/2015 possibilita ao julgador a correção de ofício de eventuais inexatidões materiais no decurso. 2. No caso dos autos, a fim de evitar dúvidas, impõe-se a alteração do termo inicial da modulação dos efeitos. 3. Ante o exposto, de ofício, altera-se o termo inicial da modulação dos efeitos, do presente recurso especial repetitivo, para a data da publicação do acórdão embargado (4/5/2018).

TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

(EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)

O esclarecimento se deu em relação ao terceiro requisito, registro na ANVISA, a fim de que ficasse claro que tal registro compreendesse a observância dos usos autorizados pela agência. Desse modo, o fornecimento de medicamento em uso off label não está abarcado pelo entendimento do STJ.

Com relação à modulação de efeitos para os processos distribuídos até 03/05/2018 não é necessário a observância dos requisitos definidos pelo repetitivo, mas somente a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

A tese fixada estabelece que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (grifos nossos)

2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3) Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Conclui-se, portanto, que se contrapondo ao aumento da judicialização do direito à saúde em nosso país, nossas cortes superiores têm adotado um posicionamento segundo o qual não é de dever do Estado o fornecimento de medicamentos experimentais ou não registrados pela Anvisa, não devendo, portanto, o Poder Judiciário intervir de maneira atécnica de nas decisões tomadas pela Anvisa, cuja competência para exercer vigilância sanitária sobre medicamentos em nosso país é soberana.

Contrariando os anseios de quem está enfermo e por vezes possui como única esperança a administração de determinado composto, o Poder Judiciário tem ainda considerado em grau máximo os reflexos econômicos que a concessão de medicamentos pelo poder público possa ocasionar, desprestigiando assim um direito fundamental e geral à saúde, em qualquer ocasião.

Destaco que o cerne da controvérsia é o fornecimento do medicamento **adrenalina autoinjetável (Penepin)**, que é importado e não tem registro na ANVISA.

Inicialmente, verifico que restou comprovada a incapacidade financeira da parte autora, menor absolutamente incapaz, representado por sua mãe, patrocinada pela Defensoria Pública.

No caso concreto, resta demonstrado que a parte autora, apresenta quadro grave de alergia a leite de vaca, com história de reação anafilática, possuindo indicação de portar o medicamento Epinefrina (Adrenalina) autoinjetável em caso de reação anafilática.

Sobre **Epinefrina (Adrenalina) autoinjetável 0,3mg**, o parecer NAT (evento 12, PAREECER1) informa que não está registrado na ANVISA e não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME. De acordo com o NAT, a ausência do registro na ANVISA impede a comercialização do medicamento em território nacional e a obtenção depende de importação.

De acordo com laudo médico, evento 1, LAUDO9, dos autos originários, emitido por profissional do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira em 02/09/2024, apresenta quadro grave de alergia à proteína do leite de vaca comprovada clínica. Apresenta reações de anafilaxia caso contato acidental com leite. Condição que põe em risco a vida da paciente por gerar parada cardiorrespiratória de forma aguda e óbito, vejamos:

LAUDO MÉDICO

Nome: Ester Santos Rodrigues

Prontuário: 66980

Data: 02/09/2024

Paciente de 13 anos, acompanhada regularmente no Serviço de Alergia e Imunologia do IPPMG/UFRJ com quadro grave de alergia a proteína do leite de vaca (julho/2024: IgE total 242; IgE específica beta-lactoglobulina 9,47; caseína 3,61; alfa-lactoalbumina 35,5; leite de vaca 16,9), apresenta reações de anafilaxia caso contato acidental com leite. Condição que põe em risco a vida da paciente por gerar parada cardiorrespiratória de forma aguda e óbito. Diante desse quadro, solicito que essa paciente tenha disponível adrenalina autoinjetável 0,5mg.

Isadora Arantes
Pediatra
CRM: 52.7116650-6

Médica ambulatório alergia/imunologia UFRJ

Conforme atestado no formulário médico (EVENTO 1 - LAUDO10), datado de 21/10/2024, a Dra. Fernanda Pinto Mariz (CRM: 52.71117-9) afirma que os medicamentos fornecidos pelo SUS (antialérgicos e corticóides) não impedem a evolução da reação para o óbito, a única medicação, segundo consensos nacionais e internacionais, capaz de impedir o óbito é a adrenalina (epinefrina).

1) Qual(is) a(s) doença(s) que acomete(m) o(a) paciente acima nominado(a)? (Indicar o(s) CID(s) correspondentes, histórico da doença e tratamentos já realizados)

Paciente com alergia à proteína do leite de vaca, com história de anafilaxia e necessidade de adrenalina. Exames (Julho/24): IgE T: 242, IgE específica para beta-lactoglobulina 9,47, caseína 3,61, alfa-lactoalbumina 35,5, leite de vaca 16,9. CID 10: T8.1; T78.0

2. O(A) paciente pode fazer uso de algum(s) do(s) medicamento(s) acima indicado(s) como alternativa terapêutica à prescrição inicialmente realizada?

() Sim.

(x) Não.

() Em parte.

3. Caso possa ser utilizada uma alternativa terapêutica, indaga-se:

a) Qual(is) do(s) medicamento(s) dispensados pelo SUS, indicados acima como substitutos à prescrição inicial, o paciente deverá fazer uso? (Indicar dosagem e posologia dos medicamentos)

Os medicamentos listados e fornecidos pelo SUS (antialérgicos e corticóides) não impedem a evolução para o óbito. A única medicação capaz de impedir esta evolução é a adrenalina (epinefrina) por via intramuscular.

b) Por quanto tempo deve o(a) paciente deve ser submetido(a) a esse tratamento?

(x) Uso contínuo.

() Tempo determinado/Período de uso: _____

() Tempo indeterminado.

4. Caso o paciente não possa fazer uso do(s) medicamento(s) dispensado(s) pelo SUS acima listado(s), em substituição àquele(s) prescrito(s), pergunta-se:

a) O paciente já fez uso de alguma das medicações acima indicada? Qual(is)? Qual foi o resultado?

As medicações listadas (fornecidas pelo SUS) não impedem o óbito. O tratamento indicado para esta finalidade é a adrenalina (epinefrina).

b) Quais o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) o paciente não pode fazer uso da(s) alternativa(s) terapêutica(s) acima apontadas (admitir múltipla marcação):

☒ É o único tratamento existente

☐ As opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes

☐ As opções disponíveis no SUS são contraindicadas. Por quê?

☐ Outro motivo. Especificar

A adrenalina é o único capaz de impedir óbito.

d) Diante da impossibilidade de substituição, qual(is) o(s) tratamento(s)/medicamento(s) indicado(s) para tratamento do paciente? (Indicar: posologia, forma farmacêutica, dose, forma de administração e princípios ativos dos medicamentos, DCB - Denominação Comum Brasileira /DCI - Denominação Comum Internacional)

ADRENALINA AUTO INJETÁVEL 0,5 mg; I.M.

e) O medicamento prescrito está Registrado na Anvisa ☒ Sim ☐ Não

f) O medicamento prescrito, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado? ☐ Sim ☐ Não ☒ Não se aplica

g) Tem Registro em país estrangeiro ☒ Sim ☐ Não. Se sim, qual país? EUA, Europa

h) Trata-se de prescrição com indicação não incluída na bula (uso off label)? ☐ Sim ☒ Não

5. Quais os benefícios esperados e os critérios ou parâmetros que serão utilizados para o acompanhamento da resposta terapêutica com o tratamento indicado?

O tratamento indicado é fundamental para resolução da anafilaxia e desta forma, impede a evolução para possível óbito. A eficácia é avaliada por parâmetros clínicos.

6. Quais os efeitos adversos esperados com o uso do medicamento indicado e os meios empregados para redução dos mesmos?

tremor, cefaleia, taquicardia, sudorese.

Evolução para óbito.

A utilização correta do medicamento:

Eliminará o risco dessas consequências? ☒ Sim () Não

Justifique:
É a única medicação capaz de reverter o quadro e impedir o óbito segundo consenso nacional e internacional.

Reduzirá esse risco? () Sim () Não

Justifique:
—

8. Há risco de vida ou de agravamento do quadro clínico atual, sendo imprescindível o uso deste medicamento?

☒ Sim.
() Não.

Justifique: É a única medicação capaz de impedir a evolução para óbito nos casos de anafilaxia segundo os consensos nacionais ou internacionais.

9. Configura urgência?

☒ Sim.
() Não.

Justifique: Pode evoluir para óbito se não for tratado adequadamente. O tratamento deve ser precoce.

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS.

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE: IPPMG/UFERS

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro/RJ

DATA: 21/10/24

*NOME DO PROFISSIONAL(prescritor): FERNANDA PINTO MARIZ

*Nº DE REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL: SR7117-9

 
ASSINATURA E CARIMBO

O Parecer do NAT destaca que, segundo orientação da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, todo indivíduo que já sofreu reações anafiláticas, especialmente por picadas de insetos ou alimentos, devem receber instruções sobre como agir em caso de reação e portar adrenalina em autoinjetores ou kits contendo ampola de solução milesimal e seringa de 1,0 ml. Afirma, ainda, que os autoinjetores de adrenalina apresentam como ponto positivo a facilidade no uso.

O parecer, apesar de confirmar que a Adrenalina autoinjetável é destinada a administração imediata em pacientes que estão determinados a ter maior risco de anafilaxia e com história de reações anafiláticas, inclusive realçando a facilidade de seu manuseio, informa que a dispensação da medicação neste formato não possui registro na ANVISA.

A substância Adrenalina possui registro na ANVISA, entretanto a tecnologia aqui pleiteada, na forma autoinjetável, ainda não teve seu uso autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com efeito, o Sistema Único de Saúde disponibiliza tratamento para anafilaxia, por meio da utilização de adrenalina (epinefrina), na apresentação não autoinjetável.

Verifica-se, portanto, que o presente caso apresenta certa peculiaridade, pois a ausência de registro na Anvisa, na verdade, diz respeito à adrenalina na forma autoinjetável, sendo certo que a adrenalina tem seu uso amplamente difundido no sistema público de saúde, cuja aplicação, também injetável, difere-se apenas quanto à necessidade de ocorrer em ambiente hospitalar.

Disso se conclui que a injeção de adrenalina tem amparo nas políticas públicas de saúde para o combate de anafilaxia, de modo que não se configura nem tratamento experimental, nem de substância desprovida de aprovação da Anvisa, nem terapia absolutamente alheia aos protocolos do SUS. A distinção reside apenas quanto à modalidade em que a injeção é ministrada.

Como a alergia alimentar tem natureza grave e a parte autora conta com apenas 13 anos de idade, a impossibilidade de acesso à adrenalina autoinjetável em caso de choque anafilático pode resultar em seu óbito. Há fundado risco de não haver tempo hábil entre a percepção dos sintomas pelo responsável e a chegada do menor a uma unidade de pronto-atendimento, onde se dispõe de adrenalina injetável disponibilizada pelo SUS, para interromper os efeitos fatais da crise.

Assim, cuidando-se de portador de alergia alimentar grave, conforme exposto no laudo médico, mostra-se inviável submeter a parte autora à alternativa terapêutica oferecida pelo SUS, cujo tratamento disponível exige certo conhecimento técnico para aplicação da adrenalina. Portanto, em situações emergenciais é imprescindível a utilização do fármaco pleiteado, visto o real risco de morte oriundo das crises anafiláticas.

Ressalta-se que, embora esta forma específica de aplicação não seja registrada na ANVISA, obviamente não se trata de medicamento experimental, uma vez que o SUS fornece Adrenalina para uso hospitalar.

Destaco abaixo decisão nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ADRENALINA AUTO-INJETÁVEL. MEDICAMENTO QUE EMBORA NÃO SEJA EXPERIMENTAL, NÃO ESTÁ REGISTRO NA ANVISA PARA A FORMA ESPECÍFICA DE APLICAÇÃO. TRATAMENTO ASSEGURADO. 1. Admite-se, em hipóteses particulares, o fornecimento de fármacos não previstos nos protocolos e relações complementares do sistema público de saúde, desde que imprescindíveis ao tratamento necessário à proteção da saúde do usuário e uma vez observados os requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). 2. Em relação à adrenalina auto-injetável, a perícia médica realizada atestou o uso altamente eficaz do medicamento na contenção de crises anafiláticas. Assim, cuidando-se de portador de alergia alimentar múltipla, mostra-se inviável submeter a parte à alternativa terapêutica oferecida pelo SUS, cujo tratamento disponível exige certo conhecimento e técnica para aplicação da adrenalina. Portanto, em situações emergenciais, é imprescindível a utilização do fármaco pleiteado, visto o real risco de morte oriundo das crises anafiláticas. 3. Embora esta forma específica de aplicação de adrenalina não esteja registrada na ANVISA, obviamente não se trata de medicamento experimental, uma vez que o SUS fornece adrenalina para uso hospitalar. Além disso, a ANVISA tem autorizado a importação da adrenalina autoinjetável (<http://www.alergopneumoped.com.br/arquivos/site/informacoes-pacientes/EpiPen-como%20adquirir.pdf>). 4. Recurso improvido. (5005202-65.2017.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GERSON LUIZ ROCHA, julgado em 13/02/2020)

Noutro prisma, sobre o tema o Supremo Tribunal Federal - STF no RE nº 657.718, relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, sessão de 18/06/2021 assentou que **a ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA não constitui óbice intransponível em matéria deste tipo específico.**

Assim, entendo que restou demonstrada a excepcionalidade da situação, o que enseja a autorização para importação do fármaco, uma vez que o medicamento é indispensável, sob pena de morte por choque anafilático.

Neste sentido, caso similar de fornecimento da medicação adrenalina auto injetável, processo de nº 5003590-42.2021.4.02.5117/RJ, julgado na sessão Virtual de 04/11/2021, e medida cautelar de nº 5003066-88.2024.4.02.5101/RJ, julgada na Sessão Ordinária de 04/03/2024.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso, confirmando a decisão do evento 3, para determinar que os réus, de forma solidária, forneçam à parte autora o medicamento adrenalina autoinjetável (Penepin), conforme prescrição do seu médico assistente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob multa diária de R\$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser aplicada no juízo de origem, devendo a parte autora apresentar receita médica atualizada a cada 6 (seis) meses. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.